Le Cercle des Généralistes
Le média de référence des médecins généralistes

Revue hebdomadaire
lecercledesgeneralistes.fr

Revue du 28 octobre 2026

La rédaction du Cercle des Généralistes · 26 min de lecture

La 4e année de médecine générale entre en application le 2 novembre 2026 : selon l'instruction des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur du 21 mai 2026, les premiers docteurs juniors consultent en autonomie supervisée, pour un an, chez des maîtres de stage agréés, facturent avec leur propre carte CPS et laissent les tickets modérateurs au maître de stage. Le ministère de la Santé en annonce plus de 3 000, dont 80 % dans des territoires en difficulté d'accès aux soins. Le décret n° 2026-985 du 23 octobre 2026, paru au Journal officiel du 24 octobre, ouvre de son côté l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée des CPTS de 6 départements, à partir du 1er décembre et pour 5 ans, avec un compte rendu au médecin traitant après chaque consultation.

Au sommaire de la semaine

4e année de médecine générale : les docteurs juniors arrivent en cabinet le 2 novembre 2

Accès direct aux IPA en CPTS : 6 départements, à partir du 1er décembre 2026 7

La semaine en bref

Budget de la Sécurité sociale 2027 : l'Assemblée nationale rejette le texte

Selon l'Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 a été rejeté en première lecture le 23 octobre 2026, après son rejet par la commission des affaires sociales. Au 28 octobre, le Sénat n'a pas publié de calendrier d'examen. Les mesures qui touchent les généralistes restent donc en suspens, dont les économies sur les indemnités journalières, que l'annexe du projet chiffrait à 1 Md€ en 2027, comme le détaillait notre dossier sur le PLFSS 2027.

4e année de médecine générale : les docteurs juniors arrivent en cabinet le 2 novembre

SITUATION

Le 2 novembre 2026, les premiers docteurs juniors de médecine générale prennent leurs fonctions, pour un an, chez des maîtres de stage agréés.

La 4e année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale, créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, entre en application le 2 novembre 2026, selon l'instruction des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur du 21 mai 2026. Les étudiants qui ont commencé leur internat à la rentrée 2023 deviennent docteurs juniors et exercent en autonomie supervisée, principalement en cabinet, en maison de santé pluriprofessionnelle ou en centre de santé, auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités. Selon un communiqué du ministère de la Santé du 14 octobre 2026, plus de 3 000 docteurs juniors commencent cette année, dont 80 % dans des territoires caractérisés par des difficultés d'accès aux soins ; selon le même communiqué, une seconde vague d'environ 500 internes suivra dès mai 2027. En Normandie, l'agence régionale de santé en annonce 168, attendus sur leur terrain de stage le 2 novembre.

L'ESSENTIEL

- **Ce qui change :** le docteur junior consulte en autonomie supervisée et facture avec sa propre carte CPS ; en cabinet, le maître de stage perçoit ses tickets modérateurs.
- **Quand :** prise de fonctions le 2 novembre 2026, pour 2 semestres, en principe dans le même cabinet.
- **Que faire :** vérifier avant le 2 novembre que le docteur junior a reçu sa carte CPS, et prévenir son assureur en responsabilité civile professionnelle.

CONTEXTE

Le docteur junior n'est plus un interne : il relève du statut des docteurs juniors des autres spécialités et demande, dans les 3 mois qui suivent sa nomination, son inscription sur un tableau spécial du conseil départemental de l'Ordre du département de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ses obligations de service sont de 10 demi-journées par semaine, dont 1 de formation universitaire et 1 de temps personnel de consolidation. Le premier stage se poursuit au second semestre par reconduction, après accord des 2 parties.

Pourquoi : selon l'instruction du 21 mai 2026, la phase de consolidation doit renforcer la formation pratique en ville, permettre une autonomie progressive et encadrée, et améliorer l'accès aux soins, en incitant à la réaliser en priorité dans les zones sous-denses.

CE QUI EST CONFIRMÉ

Sur la facturation, le docteur junior facture lui-même les actes et consultations qu'il réalise, « dans les conditions prévues par la convention, à tarifs opposables », en appliquant obligatoirement le tiers payant sur la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Une carte CPS qui lui est propre, différente de celle de l'internat, lui est délivrée. L'instruction précise qu'il « ne peut, en aucun cas, facturer des actes avec la carte CPS » du maître de stage : ce serait une fraude, et l'Assurance Maladie réalisera des contrôles.

Sur les tickets modérateurs, la totalité de ceux liés à l'activité du docteur junior revient au maître de stage, quel que soit le mode de paiement du patient, y compris pour ses gardes de permanence des soins ; si un autre maître de stage supervise ces gardes, celui-ci ne perçoit que la prime de supervision. Le docteur junior qui encaisse un ticket modérateur en espèces ou par chèque doit en reverser l'intégralité au maître de stage. À titre d'illustration, l'instruction estime que 210 consultations mensuelles du docteur junior correspondent à 1 200 € de tickets modérateurs encaissés, sur la base de l'honoraire et du taux de prise en charge moyens constatés. Selon l'instruction, en centre de santé, c'est le centre qui facture les actes du docteur junior et perçoit directement le ticket modérateur.

Côté maître de stage, l'article 4 bis de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages du troisième cycle, créé par un arrêté du 27 août 2025 et modifié par un arrêté du 13 mai 2026, lui accorde des honoraires pédagogiques de 600 € bruts par mois de stage et par étudiant, que l'université lui verse selon l'instruction ; si l'étudiant est accueilli chez plusieurs maîtres de stage, ces honoraires ne sont dus qu'une fois, au prorata du temps passé auprès de chacun. S'y ajoutent, sous conditions, une prime de 800 € bruts par mois et par étudiant s'il exerce en zone d'intervention prioritaire, en zone d'action complémentaire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, et une prime de 400 € bruts par mois et par étudiant s'il supervise le docteur junior en permanence des soins ambulatoires. Selon l'instruction, la prime de zone reste due pendant tout le stage, même si la commune sort du zonage, et l'université verse ces sommes sous forme d'honoraires, ou de salaire si le maître de stage souhaite le statut de collaborateur occasionnel du service public. Selon le communiqué du ministère du 14 octobre 2026, les maîtres de stage sont rémunérés « directement par l'Assurance maladie, à l'exception des honoraires pédagogiques relevant des universités ».

Ce même arrêté du 13 mai 2026 a supprimé l'indemnité de 1 200 € bruts par mois prévue en août 2025 pour les charges d'encadrement. Il a créé une compensation de 300 € bruts par mois si les patients exonérés de ticket modérateur représentaient entre 50 % et 63 % de la patientèle du maître de stage l'année précédente, et de 600 € à partir de 63 %, appréciée selon l'instruction sur le relevé individuel d'activité et de prescriptions. Il prévoit 550 € bruts par mois pour un cabinet principal situé dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle. Selon l'instruction, une compensation de 1 200 € bruts par mois, versée par l'agence régionale de santé, est due si le stage est totalement interrompu de façon imprévisible, par exemple pour longue maladie ou maternité, pendant au moins un mois calendaire complet.

Côté docteur junior, la rémunération est versée par le centre hospitalier universitaire : selon l'instruction, 2 375 € bruts par mois et une prime d'autonomie supervisée de 5 000 € bruts par an, auxquels l'arrêté du 27 août 2025 ajoute une prime d'activité et une indemnité en zone d'intervention prioritaire, soit 500 € bruts par semestre si son activité dépasse en moyenne 200 actes par mois, et 1 000 € bruts par mois en stage en zone d'intervention prioritaire.

Sur la permanence des soins, selon l'instruction, le docteur junior peut participer, s'il est volontaire et avec l'accord de son maître de stage, à la régulation téléphonique, après une formation au SAMU-Centre 15, et aux gardes. Il est inscrit sur le tableau de garde en « doublon » avec le maître de stage qui le supervise ; celui-ci n'a pas à être présent, mais doit être joignable par téléphone à tout moment. En régulation, le docteur junior ne doit pas être le seul régulateur de la permanence des soins sur le plateau du Centre 15, et ne peut pas réguler à distance, même si son maître de stage le fait. Un repos de sécurité suit chaque garde, sans dérogation. Selon l'arrêté du 13 mai 2026 modifiant l'arrêté du 27 août 2025, le docteur junior perçoit 50 € bruts par heure de régulation et

422,03 € bruts par garde de 12 heures. Côté hôpital, l'arrêté du 23 octobre 2026, paru au Journal officiel du 25 octobre, inscrit la médecine générale dans la liste des spécialités pour lesquelles le docteur junior peut être autorisé, à sa demande, à participer au service des gardes et astreintes médicales.

Sur l'agrément, selon l'instruction, le directeur général de l'agence régionale de santé agrée les terrains de stage, par spécialité et par phase de formation, et le médecin doit être lié par convention au centre hospitalier universitaire de la subdivision. Le premier agrément vaut 1 an, puis il est renouvelable tous les 5 ans. Depuis le 1er septembre 2025, un centre de santé ou une maison de santé constituée en société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut aussi être agréé comme structure.

Sur l'encadrement, selon l'instruction, un maître de stage peut encadrer au plus 2 étudiants de troisième cycle en même temps, si les stages sont à temps plein. L'agrément est réexaminé si l'activité du docteur junior dépasse durablement 2 400 consultations par semestre en moyenne.

CE QUI POSE QUESTION

Au 28 octobre 2026, 6 questions restent ouvertes.

Chaque docteur junior aura-t-il sa carte CPS le 2 novembre ? L'instruction de mai annonçait une procédure de réception des cartes transmise aux étudiants « avant l'été 2026 », et une circulaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 21 mai prévoyait leur envoi à partir de juin. MG France rapporte que, selon le ministère, « plus de 99 % des logiciels seraient désormais paramétrés et testés » pour ces cartes. Au 28 octobre, nous n'avons trouvé aucune information officielle sur le nombre de cartes délivrées, à 5 jours de la prise de fonctions.

Les docteurs juniors vont-ils vraiment là où les médecins manquent ? Le ministère de la Santé annonce que 80 % d'entre eux exerceront en zone d'intervention prioritaire, en zone d'action complémentaire ou en quartier prioritaire de la politique de la ville, sans publier la liste des communes concernées. Les agences régionales de santé publient leurs chiffres une à une, par département et non par type de zone. Celle de Normandie détaille ses 168 docteurs juniors : 59 en Seine-Maritime, 32 dans la Manche, 31 dans l'Eure, 27 dans le Calvados et 19 dans l'Orne. Celle d'Île-de-France en annonce plus de 400, celle des Pays de la Loire 186. En Centre-Val de Loire, selon l'agence, 94 des 102 postes ambulatoires ouverts ont été pourvus.

Qui verse quoi au maître de stage ? L'instruction de mai fait verser les compensations par l'université et l'indemnité d'interruption par l'agence régionale de santé ; le communiqué du ministère du 14 octobre annonce un paiement direct par l'Assurance Maladie, hors honoraires pédagogiques. MG France rapporte que l'Assurance Maladie assurera le versement des primes de zone, « qui serait trimestriel », mais « reconnaît que ses circuits actuels ne sont pas techniquement adaptés », et que, « selon les universités, le paiement pourra être mensuel ou semestriel » pour les honoraires pédagogiques. Aucun texte lu ne précise le calendrier des premiers versements.

Le patient vu par le docteur junior reste-t-il dans le parcours de soins de son médecin traitant ? Selon l'Assurance Maladie, le patient qui consulte un autre médecin du cabinet de son médecin traitant reste dans le parcours, et il est moins bien remboursé s'il en sort. Le docteur junior facture sous sa propre carte, et l'instruction ne dit ni s'il est assimilé à ce médecin, ni ce que deviennent les déclarations de médecin traitant des patients qu'il suit pendant un an.

Le maître de stage qui emploie un assistant médical sera-t-il pénalisé ? Les consultations du docteur junior sont facturées sous sa propre carte. Selon MG France, si cette activité a une incidence sur la file active du maître de stage, le ministère répond seulement que « la situation devra être réglée au cas par cas avec la CPAM ».

Qui répond d'une erreur du docteur junior ? L'instruction le fait exercer « par délégation et sous la responsabilité » de son maître de stage. Selon MG France, le ministère indique seulement que « le cadre actuel s'appliquera », sans dire si l'assurance du maître de stage couvre un docteur junior qui consulte seul.

L'IMPACT FINANCIER & ORGANISATIONNEL

Pour un maître de stage en cabinet ou en maison de santé, l'équation change par rapport à l'interne. Le docteur junior apporte une activité propre, facturée sous sa carte, dont le maître de stage perçoit les tickets modérateurs, environ 1 200 € par mois pour 210 consultations selon l'estimation de l'instruction. S'y ajoutent 600 € bruts d'honoraires pédagogiques. Avec la prime de zone prioritaire de 800 € et la prime de supervision des gardes de 400 €, le total peut atteindre 3 000 € par mois et par docteur junior, avant charges, selon un calcul du Cercle sur ces montants. Le ministère avance, sans le détailler, un montant « pouvant aller jusqu'à 3 200€ / mois en plus de l'activité médicale ».

Une patientèle très exonérée rapporte peu de tickets modérateurs : c'est l'objet de la compensation de 300 à 600 € par mois créée en mai 2026. Un cabinet dont au moins la moitié des patients sont exonérés, en ALD ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire notamment, a intérêt à retrouver son relevé individuel d'activité et de prescriptions de l'année précédente, qui sert de base.

Côté organisation, le cabinet doit prévoir un bureau, un agenda et un poste de facturation qui accepte la carte du docteur junior. La responsabilité change aussi d'échelle : le docteur junior consulte seul, mais sous la responsabilité de son maître de stage, selon l'instruction. En centre de santé, l'instruction exige que les postes soient à jour de la dernière version SESAM-Vitale, faute de quoi le docteur junior ne peut pas facturer.

LE REGARD DU CERCLE

La 4e année arrive avec des textes publiés à temps, et c'est une bonne nouvelle pour les cabinets : un docteur junior qui consulte en autonomie pendant un an dans le même cabinet, c'est du temps médical en plus et un futur confrère qui connaît déjà le territoire.

Mais l'État a changé la façon de payer l'encadrement. L'indemnité de 1 200 € par mois, qui compensait « les charges liées à l'encadrement spécifique », a été supprimée en mai : le maître de stage est désormais payé, pour une large part, par les tickets modérateurs que produit le docteur junior. La formation est donc financée par le volume de consultations. Le cabinet à patientèle très exonérée y perd, malgré une compensation de 300 à 600 € par mois, et l'incitation pousse au rendement, alors que l'agrément est réexaminé au-delà de 2 400 consultations par semestre en moyenne. Le maître de stage doit rester celui qui forme, pas celui qui remplit l'agenda.

Les angles morts, eux, retombent sur le maître de stage. Sans carte CPS au 2 novembre, son docteur junior ne peut pas facturer. Il répond d'un médecin en formation qui consulte seul, sans que le ministère dise quelle assurance le couvre. Ses patients vus par le docteur junior pourraient sortir du parcours de soins si l'Assurance Maladie ne les y rattache pas. Son assistant médical est renvoyé au « cas par cas », et ses primes passent par des circuits que l'Assurance Maladie reconnaît inadaptés, selon MG France.

Avant le 2 novembre, l'Assurance Maladie doit dire que les consultations du docteur junior restent dans le parcours de soins du médecin traitant, et garantir au maître de stage qui emploie un assistant médical que cette activité ne lui sera pas reprochée. Le ministère doit publier le nombre de cartes délivrées, le calendrier des premiers versements et la répartition des affectations par type de zone.

RECOMMANDATIONS

- **Maître de stage qui accueille un docteur junior** : Vérifier avant le 2 novembre que le docteur junior a reçu sa carte CPS et que le poste du cabinet l'accepte, puis prévenir son assureur en responsabilité civile professionnelle qu'il supervise un docteur junior qui consulte seul, sous sa responsabilité.
- **Médecin qui veut accueillir un docteur junior en 2027** : Demander au département universitaire de médecine générale de sa faculté les dates de la prochaine formation à la maîtrise de stage, puis déposer sa demande d'agrément auprès de l'agence régionale de santé.

Sources et traçabilité de ce dossier en fin de revue

Accès direct aux IPA en CPTS : 6 départements, à partir du 1er décembre 2026

SITUATION

Dans 6 départements, des patients pourront consulter un IPA de leur CPTS sans passer par un médecin, à partir du 1er décembre 2026 et pendant 5 ans.

Le décret n° 2026-985 du 23 octobre 2026, paru au Journal officiel du 24 octobre et entré en vigueur le lendemain, organise l'expérimentation prévue par l'article 1er de la loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. L'arrêté du 23 octobre 2026, paru au même Journal officiel, retient l'Hérault, le Loiret, la Martinique, Mayotte, le Val-d'Oise et l'Yonne, sélectionnés à l'issue d'un appel à projet. L'expérimentation débute le 1er décembre 2026 pour 5 ans.

L'ESSENTIEL

- **Ce qui change :** dans 6 départements, un IPA qui exerce dans une CPTS pourra recevoir un patient sans orientation médicale, prescrire dans les limites fixées par arrêté, puis adresser un compte rendu au médecin traitant.
- **Quand :** décret en vigueur depuis le 25 octobre 2026 ; expérimentation à partir du 1er décembre 2026, pour 5 ans.
- **Que faire :** dans ces départements, adhérer à sa CPTS et y fixer, avant le 1er décembre, le circuit des comptes rendus et un délai de reprise des patients réorientés.

CONTEXTE

Depuis le décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, l'infirmier en pratique avancée peut déjà prendre directement en charge des patients lorsqu'il exerce dans les conditions prévues au II de l'article L. 4301-2 du code de la santé publique. Selon l'Ordre national des infirmiers, il s'agit notamment des établissements de santé et médico-sociaux, des centres de santé, des maisons de santé et des équipes de soins primaires et spécialisés. Ce décret de 2025 lui permet aussi de prescrire des produits de santé ou des prestations, soumis ou non à prescription médicale obligatoire, dont la liste est fixée par arrêté après avis de l'Académie nationale de médecine ; cet arrêté peut subordonner la prescription à un diagnostic médical préalable. Il lui impose, quand une situation dépasse son champ de compétences, d'adresser le patient « sans délai » à son médecin traitant et d'en informer « expressément » ce dernier ; en l'absence de médecin traitant, il reporte l'information dans le dossier médical partagé et oriente le patient vers un médecin ou une structure adaptée.

Pour les IPA qui exercent en CPTS, la loi du 19 mai 2023 prévoit une expérimentation de 5 ans, dans 6 départements au plus dont 2 d'outre-mer, que le décret du 23 octobre 2026 met en œuvre. Le 14 octobre 2026, le ministère de la Santé a aussi annoncé son objectif de doubler, dès 2027, le nombre d'IPA formés, et prévoit pour cela de supprimer la durée minimale d'exercice préalable à l'accès à la pratique avancée et d'ouvrir effectivement la validation des acquis de l'expérience aux IPA. Le Cercle avait présenté en juillet la position du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui juge « irremplaçable » le rôle du médecin dans la coordination des soins, dans notre article sur l'accès direct aux IPA.

CE QUI EST CONFIRMÉ

Sur les infirmiers concernés, le décret vise l'IPA dont le lieu d'exercice est situé dans l'un des 6 départements. Il déclare sa participation au directeur général de l'agence régionale de santé, au moyen d'une application sur le site internet de l'agence, et joint un document qui justifie son exercice dans une CPTS de l'un des 6 départements. L'agence publie sur son site, département par département, la liste des IPA autorisés à participer, et transmet leurs noms aux organismes locaux de sécurité sociale. Un IPA peut entrer dans l'expérimentation jusqu'à 6 mois avant sa fin.

Sur la prise en charge, l'IPA autorisé « peut, à titre expérimental, prendre en charge directement les patients ». En cas de besoin, le patient est réorienté vers son médecin traitant ou, le cas échéant, vers un médecin impliqué dans sa prise en charge ou exerçant dans la CPTS, ou, en cas d'impossibilité, vers tout autre médecin. Le décret ne fixe ni liste de motifs de consultation ni catégorie de patients.

Sur les prescriptions, le décret du 23 octobre ne fixe pas de liste propre : ce que l'IPA peut prescrire relève de l'arrêté du 25 avril 2025. Tout IPA peut notamment prescrire un arrêt de travail jusqu'à 3 jours, des transports sanitaires, des antalgiques de palier 1 et des inhibiteurs de la pompe à protons, et, sous condition d'une formation définie par arrêté, de la fosfomycine-trométamol pour une cystite chez la femme de 16 à 65 ans sans facteur de risque de complication, ou de l'amoxicilline pour une angine à test rapide positif à partir de 10 ans. L'IPA du domaine des pathologies chroniques stabilisées peut aussi, « sans diagnostic médical préalable », prescrire un traitement antihypertenseur de première ligne pour une hypertension de grade 1 sans retentissement, à l'exclusion des bêtabloquants, ou un traitement hypoglycémiant de première ligne chez un patient diabétique de type 2. Ces prescriptions « ne peuvent être renouvelées sans concertation médicale ».

Côté médecin traitant, à l'issue de la consultation, un compte rendu des soins réalisés par l'IPA lui est adressé, ou, le cas échéant, au médecin impliqué dans la prise en charge ou exerçant dans la CPTS, « par tout moyen garantissant la confidentialité des échanges et la sécurisation des données transmises ». Le compte rendu est reporté dans le dossier médical partagé ou, à défaut, dans le dossier informatisé du patient.

Sur l'évaluation, chaque agence régionale de santé évalue l'expérimentation sur son territoire. Elle dresse un état des lieux et centralise chaque année des informations sur la qualité de la prise en charge, notamment le nombre d'IPA participants, le nombre de patients reçus en accès direct et leurs motifs de consultation, le nombre moyen de consultations et le nombre d'actes, le nombre de dossiers médicaux partagés mis à jour, les événements indésirables et le pourcentage de patients orientés vers un médecin. Le décret a été pris après les avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 14 avril 2026, de la Haute Autorité de santé du 2 juillet 2026, de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole du 13 août 2026, et des conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 8 septembre 2026. Selon la loi du 19 mai 2023, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard 6 mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation qui « se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation ».

CE QUI POSE QUESTION

Au 28 octobre 2026, 3 questions restent ouvertes.

Comment la consultation en accès direct en CPTS sera-t-elle facturée ? La loi du 19 mai 2023 a modifié l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à la convention nationale des

infirmiers la prise en charge des actes réalisés par les IPA, « le cas échéant sans adressage préalable de la part d'un médecin ». Une décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 8 septembre 2026, parue au Journal officiel du 22 octobre, crée à partir du 6 novembre une consultation IPA cotée PAI 2,1, facturable 4 fois par an et par patient, et des forfaits de suivi en cas d'accès direct, dans les situations « définies par le code de santé publique ». L'expérimentation en CPTS relève, elle, de la loi de 2023 et du décret du 23 octobre, qui ne fixe aucun tarif ; aucun texte ne dit si ces cotations s'y appliquent.

Dans quel délai le médecin traitant reprendra-t-il un patient réorienté ? Le décret du 23 octobre prévoit une réorientation « en cas de besoin », sans fixer de délai. Le décret de janvier 2025 impose à l'IPA, quand la situation dépasse ses compétences, d'adresser le patient « sans délai » à son médecin traitant pour permettre une prise en charge médicale « dans un délai compatible avec l'état du patient », sans dire qui garantit ce délai.

Sur quels critères de réussite l'expérimentation sera-t-elle jugée ? Le décret confie l'évaluation aux agences régionales de santé, territoire par territoire, et liste des données à recueillir, sans fixer de seuil de réussite. La loi prévoit un rapport d'évaluation au Parlement, sans en fixer les critères.

L'IMPACT FINANCIER & ORGANISATIONNEL

Pour un généraliste de ces 6 départements, une partie de ses patients pourra consulter d'abord l'IPA de la CPTS. Il recevra alors un compte rendu à lire et à intégrer au dossier, des patients réorientés à reprendre, et parfois un traitement instauré sans lui, dont le renouvellement suppose une concertation médicale. Le décret ne prévoit aucune rémunération du médecin traitant pour ce travail de coordination.

L'organisation repose sur la CPTS : c'est l'exercice dans la CPTS qui ouvre l'accès direct, et c'est vers un médecin impliqué dans sa prise en charge ou exerçant dans la CPTS que le patient peut, le cas échéant, être réorienté à la place de son médecin traitant. Le généraliste qui n'est pas membre de sa CPTS recevra les comptes rendus de ses patients sans participer à l'organisation du circuit.

Hors de ces 6 départements, rien ne change pour les IPA en CPTS ; l'accès direct reste possible, depuis janvier 2025, dans les établissements de santé et médico-sociaux et dans les structures d'exercice coordonné prévus par la loi.

LE REGARD DU CERCLE

Le décret encadre sérieusement l'accès direct. L'IPA doit exercer dans une CPTS et se déclarer à l'agence régionale de santé, le compte rendu au médecin traitant est obligatoire après chaque consultation et rejoint le dossier médical partagé ou, à défaut, le dossier informatisé du patient, et l'évaluation suivra les événements indésirables et le pourcentage de patients orientés vers un médecin. Pour un patient qui n'obtient pas de rendez-vous, une consultation infirmière qualifiée, suivie d'un compte rendu à son médecin, vaut mieux qu'une absence de consultation.

Mais le décret fait reposer la sécurité du dispositif sur le médecin traitant sans le reconnaître. C'est lui qui reçoit les comptes rendus, reprend les patients réorientés et répond quand la situation dépasse l'IPA, sans délai fixé, sans moyen dédié et sans rémunération. L'IPA pourra instaurer, sans diagnostic médical préalable, un antihypertenseur ou un antidiabétique de première ligne ; le médecin traitant le découvrira par compte rendu, et le renouvellement passera par une « concertation médicale » que personne n'organise. La liste du décret, qui n'est pas limitative, cite le pourcentage de patients orientés vers un médecin, mais ni le délai de leur reprise ni les consultations faites 2 fois pour le même motif. Le Cercle demande que les agences régionales de santé mesurent ces 2 points dès la première année : ce sont eux qui diront si l'accès direct a libéré du temps médical ou s'il en a consommé.

La suite se joue dès maintenant. Le ministère veut doubler dès 2027 le nombre d'IPA formés, la loi demande au rapport final de se prononcer « sur la pertinence d'une généralisation », et l'Ordre national des infirmiers veut que l'expérimentation se traduise, « à terme », par « un accès direct pérenne et généralisé pour tous les patients ». Le circuit que les CPTS de ces 6 départements vont fixer servira de modèle. Le généraliste qui siège dans sa CPTS pourra en écrire les règles ; celui qui reste en dehors en recevra les comptes rendus.

RECOMMANDATIONS

- **Médecin installé dans l'un des 6 départements** : Adhérer à sa CPTS s'il n'en est pas membre, puis y faire fixer, avant le 1er décembre, le canal sécurisé des comptes rendus et un délai de reprise des patients réorientés.

Sources et traçabilité de ce dossier en fin de revue

Sources de la revue

4e année de médecine générale : les docteurs juniors arrivent en cabinet le 2 novembre

Instruction interministérielle n° DGOS/RH2/DGESIP/2026/44 du 21 mai 2026 relative à la mise en œuvre de la quatrième année du diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine générale (Bulletin officiel du 28 mai 2026)

Décret n° 2025-850 du 27 août 2025 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale

Arrêté du 27 août 2025 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale

Arrêté du 27 août 2025 relatif à la rémunération des praticiens agréés-maîtres de stage des universités accueillant des docteurs juniors en médecine générale

Décret n° 2026-370 du 13 mai 2026 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale lors de leur participation à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique

Arrêté du 13 mai 2026 modifiant l'arrêté du 27 août 2025 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale

Arrêté du 13 mai 2026 modifiant l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine

Ministère de la Santé, Démographie des professionnels de santé : une hausse historique des effectifs formés et de nouvelles mesures pour renforcer l'accès aux soins (14 octobre 2026)

Arrêté du 23 octobre 2026 relatif à la liste des spécialités pour lesquelles le docteur junior peut être autorisé à participer, à sa demande, au service des gardes et astreintes médicales pris pour application de l'article R. 6153-1-5 du code de la santé publique

ARS Normandie, Docteurs juniors : un levier d'attractivité au service des professionnels et des territoires (30 septembre 2026)

ARS Île-de-France, Plus de 400 docteurs juniors poursuivent leur formation au plus près des territoires franciliens (12 octobre 2026)

ARS Pays de la Loire, Quatrième année de médecine générale : 33 docteurs juniors en Maine-et-Loire (16 octobre 2026)

ARS Centre-Val de Loire, Docteurs juniors en médecine générale : une nouvelle étape de formation au service des territoires (1er octobre 2026)

Conseil national de l'Ordre des médecins, circulaire n° 2026-027 du 21 mai 2026, docteurs juniors de médecine générale

Assurance Maladie, Le rôle du médecin traitant et le parcours de soins coordonnés

MG France, 4e année D.E.S. MG : trop d'incertitudes (7 octobre 2026)

Traçabilité : instruction interministérielle du 21 mai 2026, publiée au Bulletin officiel du 28 mai 2026, lue en entier ; décrets n° 2025-850 et n° 2026-370, arrêtés du 27 août 2025 et du 13 mai 2026, lus en entier dans leur version du Journal officiel ; arrêté du 23 octobre 2026 sur les gardes et astreintes des docteurs juniors, Journal officiel n° 250 du 25 octobre 2026, lu en entier ; ministère de la Santé, communiqué du 14 octobre 2026 ; agences régionales de santé de Normandie, d'Île-de-France, des Pays de la Loire et du Centre-Val de Loire ; Conseil national de l'Ordre des médecins, circulaire n° 2026-027 ; Assurance Maladie (ameli.fr), pour les règles du parcours de soins. MG France est cité pour ce qu'il rapporte des réponses du ministère et de l'Assurance Maladie, faute de publication officielle sur ces points.

Accès direct aux IPA en CPTS : 6 départements, à partir du 1er décembre 2026

Décret n° 2026-985 du 23 octobre 2026 relatif à l'expérimentation permettant aux infirmiers en pratique avancée participant à une communauté professionnelle territoriale de santé de prendre en charge directement les patients

Arrêté du 23 octobre 2026 fixant la liste des territoires participant à l'expérimentation permettant aux infirmiers en pratique avancée participant à une communauté professionnelle territoriale de santé de prendre en charge directement les patients

Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025 relatif aux conditions de l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée

Arrêté du 25 avril 2025 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R. 4301-3 du code de la santé publique

Décision du 8 septembre 2026 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'Assurance maladie

Loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, article 1er

Ministère de la Santé, Démographie des professionnels de santé : une hausse historique des effectifs formés et de nouvelles mesures pour renforcer l'accès aux soins (14 octobre 2026)

Ordre national des infirmiers, Accès direct aux infirmiers en pratique avancée : l'Ordre national des infirmiers salue une nouvelle étape franchie pour améliorer l'accès aux soins (26 octobre 2026)

Traçabilité : décret n° 2026-985 et arrêté du 23 octobre 2026, Journal officiel n° 249 du 24 octobre 2026, lus en entier ; décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, lu en entier ; arrêté du 25 avril 2025, Journal officiel n° 102 du 30 avril 2025, et décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 8 septembre 2026, Journal officiel n° 247 du 22 octobre 2026, lus en entier ; loi n° 2023-379 du 19 mai 2023, article 1er, dans sa version en vigueur au 27 octobre 2026 ; ministère de la Santé, communiqué du 14 octobre 2026. L'Ordre national des infirmiers est cité comme acteur, pour la liste des structures où l'accès direct est déjà possible et pour sa position.